

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	協助插鼻胃管法 Assistance Insertion of Nasogastric Tube				
編號	A31000-Q05-W-A21	制定者	ER 詹淑惠	公布日期	89 年 04 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 3.6 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員能正確協助醫師操作插鼻胃管技術。

二、範圍

護理部各單位，除兒科單位不適用（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

- 1.無法由口進食的病人由此供應營養素或藥物。
- 2.提供鼻胃管灌洗，稀釋胃內毒素及降低巴比妥藥物吸收。
- 3.抽取胃液供診斷性檢查。
- 4.執行胃減壓術，引流過多胃內液體和空氣，避免腹脹或嘔吐。

（二）用物準備

- 1.治療盤，內置下列用物：

灌食空針 1 支、棉籤 1 支、杯子 1 個（內盛溫開水約 20 cc）、膠布或紙膠 1 條（約 8 公分）、清潔手套 1 付、安全別針 1 支（視需要）。

- 2.彎盆 1 個。
- 3.鼻胃管 1 條（成人 12~18Fr.）。
- 4.水溶性潤滑液：K-Y Jelly 或 2% Xylocaine Jelly 少許。
- 5.聽診器 1 付。
- 6.手電筒 1 支（視需要）。
- 7.便盆 1 個（視需要）。

主題名稱	協助插鼻胃管法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A21	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	2/7

8.引流瓶 1 個（視需要）。

9.治療巾（視需要）。

（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1.核對電腦 HIS 系統於護理執行，核對預定執行醫囑，並於核對狀態核簽“正確”，並確認鼻胃管管路同意書是否簽署完整。	
2.辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋插鼻胃管的目的、過程及注意事項。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
3.詢問病人是否需用便盆或事先解尿排空膀胱。	避免技術進行中，病人想如廁。
4.洗手、準備物品。	
5.至病人單位，再次核對病人。	
6.予拉床簾及開燈。	
7.醫師戴清潔手套。	
8.視需要取手電筒檢視病人鼻腔，與其討論決定插管部位。	阻塞的鼻孔、鼻部骨折、鼻中膈彎曲者，均不宜由鼻部插管，可改由口插入，以避免造成不適或傷害。
9.搖高床頭，協助病人採坐臥式或坐姿，若無法坐起則微抬高床頭，協助其右側臥。	採半坐臥容易讓管子由鼻腔經食道向下滑動入胃，而採右側臥式，係依解剖結構使管子易於進入胃部。
10.視需要鋪治療巾於病人頸部及胸前，必要時以安全別針固定之。	
11.將彎盆及衛生紙置於病人及醫護人員使用方便取用處。	以備插管時，若引起嘔吐現象，可隨時取之盛裝嘔吐物及擦拭皮膚。
12.取下眼鏡及活動假牙。	取下活動假牙則為避免不慎滑脫吞入胃內。
13.取棉籤清潔鼻孔。	避免插管時將污物推入食道，引起腸道感染、腹瀉。
14.護理人員打開鼻胃管包，醫師握住管子末端，一面抽出鼻胃管同時將它盤繞於手指上，以維持管子的清潔狀態。	
15.手持鼻胃管尖端，測量應插入之長度（成人約 45-55 公分）後，並標示記號。	測量鼻胃管插入的長度： 1. 成人的測量法-- (1)自鼻尖經耳垂到劍突(Nose-Ear-Xiphoid;NEX) NEX – 50 (2)($\frac{\text{NEX}}{2}$ + 50)公分 2. 一般中等身材的成人由鼻至胃的長度約 45-55 公分，平均值為 50 公分左右。

主題名稱	協助插鼻胃管法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A21	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	3/7

步驟	說明
16. 以少量水溶性潤滑液潤滑鼻胃管尖端約 15-20 公分。	1. K-Y Jelly 可減少鼻胃管與組織黏膜的摩擦阻力；2% xylocaine 不但能減少摩擦阻力，而且有麻醉止痛功能，適用於較敏感的病人。 2. 不可用油性潤滑劑（如凡士林、甘油），避免誤入氣管時，造成吸入性肺炎。 3. 需要取胃液做細胞學檢查時，需予生理食鹽水或開水當潤滑劑，以免影響診斷結果。
17. 協助病人將頭部向胸前微屈，以利會厭軟骨關閉氣管通道，防止鼻胃管進入氣管內。	
18. 醫師手握住鼻胃管尖端約 8-10 公分處，由鼻孔沿著鼻腔底部輕輕向前推進，當鼻胃管進入口咽部時稍作停頓，一方面教導病人做吞嚥動作，同時醫師將鼻胃管配合其吞嚥動作推入，促使鼻胃管能順利滑入食道至胃內。	病情許可者可讓病人喝少許開水。若遇到阻力無法順利推入時，需將管子回抽一小段，或用手指將管子旋轉 180 度，再嘗試推入，不可強行將管子推入，避免組織受傷。若病人出現急劇咳嗽、發紺或呼吸困難現象，可能是鼻胃管誤入氣管，應立即拔出，重新插管。
19. 當鼻胃管深入至標示記號處時，以膠布暫時固定於鼻樑。	暫時固定的目的在於避免管子滑脫或移位。
20. 測試鼻胃管是否確實在胃內，下列四種方法：	除非所抽出之胃液呈現異常的顏色外，須再將胃液打回胃內，以維持消化功能及體內電解質之平衡。
(1) 以灌食空針接在鼻胃管末端開口，反抽可抽出胃液。	
(2) 置聽診器於胃部，以灌食空針打入約 10-20 cc 的空氣，此時可由聽診器聽到空氣進入胃的聲音。	抽出打入的空氣，可減少病人的腹脹不適。
(3) 將鼻胃管的末端放在水中，觀察呼氣時有無連續性水泡。	若鼻胃管插在氣管內，病人每次呼氣時均會出現氣泡。
(4) 將鼻胃管末端靠近耳旁，感覺是否有呼氣聲。	若有呼氣聲，則鼻胃管是插入氣管中。
21. 確定管子插入無誤後，蓋上鼻胃管之塑膠蓋，避免空氣侵入導致腹脹不適，並防止胃液流出。	不建議使用反折鼻胃管法，避免細菌自反折處入侵。
22. 取下暫時固定之膠布，撕下長約 7-8 公分的膠布剪成「人」形約 3-4 公分，固定於鼻樑並纏繞於鼻胃管上。	固定膠布時，注意管子是否壓迫到鼻腔皮膚，預防壓力性損傷。
23. 移去治療巾、安全別針，並將過長的管子盤繞後，固定於病人衣服上。	
24. 用衛生紙清除鼻腔和鼻胃管處的潤滑液及黏液。	避免形成黏液性痂皮，以增加舒適感。
25. 拉開床簾，並整理病人單位。	
26. 清潔用物後，歸回原位。	

主題名稱	協助插鼻胃管法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A21	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	4/7

步驟	說明
27. 工作後洗手。	
28. 在電腦 HIS 系統於護理執行，已完成執行醫囑，於執行狀態核簽“執行”。	
29. 記錄：插鼻胃管的原因、時間、尺寸、固定位置及病人反應。	

(四) 注意事項

1. 插鼻胃管之過程中，護理人員必須隨時觀察病人的反應，藉由教導其深呼吸及交談來轉移病人的注意力，使其肌肉鬆弛，鼻胃管易於插入。
2. 插管後不可立即餵食，至少需休息 15～20 分鐘，待胃肌收縮平息後再餵食；初次餵食時，建議先餵食 20-30 cc 溫開水。
3. 長期使用鼻胃管餵食者，視其材質及醫院常規定期更換（一般橡膠為一週；Silicon 材質為一個月；PU 材質為三個月），需重新再插入者，則應插另一側鼻孔。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

主題名稱	協助插鼻胃管法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A21	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	5/7

六、參考資料

- (一) 唐儷芳(2012)．營養的需要．唐儷芳著，圖解基本護理學（初版，194-217 頁）．台北市：五南。
- (二) 廖秀珠(2013)．營養的需要．王月琴等編著，基本護理學（下冊）（六版，12-1—12-62 頁）．台北市：永大。
- (三) 蘇麗智(2014)．營養的需要．蘇麗智．簡淑貞．劉波兒等編著，實用基本護理學（下冊）（六版，106-115 頁）．台北市：華杏。
- (四) 劉森永(2023)．發明兩截式鼻胃管之經驗分享。彰化護理，30(2)，153-154。

七、附件

(略)

主題名稱	協助插鼻胃管法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A21	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.04.30	1.0	新制定	89 年 04 月 30 日 護理部技術標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.04.06	2.1	增加：取下暫時固定之膠布，撕下長約 7-8 公分的膠布剪成「人」形約 3-4 公分，固定於鼻樑並纏繞於鼻胃管上。	100 年 04 月 06 日護理部技術標準委員會通過
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.03.17	3.1	1. 第三項第(二)目內容將 50cc 灌食空針改為灌食空針。 2. 第三項第(三)目之 4、5、18、21 部份內容刪修。 3. 更改第六項參考資料。	104 年 03 月 17 日 護理部技術標準委員會通過
105.03.15	3.2	1. 原主題名稱：插鼻胃管法；改為~協助插鼻胃管法。 2. 目地內容修正：護理人員能正確協助醫師操作插鼻胃管技術。 3. 第三項說明內容 HIS2008 統稱為 HIS 系統。 4. 增修第三項第(三)目之 2 病人辨識說明。 5. 更改第六項參考資料。	105 年 03 月 15 日 護理部技術標準委員會通過
106.03.14	3.3	1. 第三項(三)目之 3、15、20(2)、21 部份內容刪修。 2. 第三項(四)目之注意事項之 2 部份內容增修。 3. 更新第六項參考資料。	106 年 03 月 14 日 護理部技術標準委員會通過
107.03.22	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.03.18	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第三目之 22 說明壓瘡更改為壓力性損傷。 3. 第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 03 月 18 日護理技術組會議通過； 108 年 04 月 10 日護理長會議通過；108 年 04 月 23 日督導會議通過公布。
109.03.16	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	協助插鼻胃管法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A21	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
110.04.06	3.5	第三項第三目步驟及要點說明之 1 新增放置鼻胃管前需確認鼻胃管管路同意書是否簽署完整。	110 年 02 月 04 日護理技術組會議通過；110 年 03 月 17 日護理長會議通過；110 年 04 月 06 日督導會議通過公布
111.03.21	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.03.20	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.03.18	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.03.17	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.04.07	3.6	1.第三項第一目第 2 點新增：及降低巴比妥藥物吸收。 2.第六項參考資料修訂。	115 年 03 月 16 日護理技術組會議通過；115 年 03 月 18 日護理長會議通過；115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。